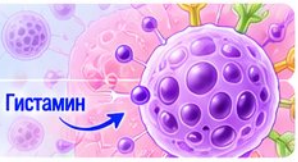
ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



Противоаллергические средства — препараты, применяемые для профилактики и лечения аллергических реакций.

1 Механизм развития аллергической реакции

При аллергической реакции из тучных клеток выделяется гистамин, который воздействует на чувствительные рецепторы тканей и вызывает симптомы.



2 Классификация противоаллергических средств

Противоаллергические препараты делятся на три большие группы:

1. Глюкокортикостероиды
2. Стабилизаторы мембран тучных клеток
3. Антигистаминные средства

3 Глюкокортикостероиды

Глюкокортикостероиды относятся к наиболее сильным противоаллергическим средствам.



4 Стабилизаторы мембран тучных клеток

Стабилизаторы мембран тучных клеток предотвращают выход медиаторов аллергической реакции (гистамина, брадикинина, интерлейкинов и др.) из тучных клеток, укрепляя их мембрану.

Механизм действия

- Первая стадия аллергической реакции — взаимодействие антигена и антитела на мембране тучной клетки.
- Мембрана в месте взаимодействия становится проницаемой, и медиаторы выходят из клетки.
- Стабилизаторы укрепляют мембрану, чтобы она оставалась целой и удерживала медиаторы внутри клетки.



Препараты

- Кромогликат натрия
(Кромоглин, кромоглициевая кислота, Интал).
- Кетотифен.





Особенности препаратов

- Кромоглин и Интал — торговые названия; кромоглициевая кислота и кромогликат натрия — формы одного вещества.
- Кетотифен — отдельный препарат этой группы.
- Часть «фен» в названии кетотифена связана с фенольной группой; в большинстве случаев такая часть указывает на способность препарата воздействовать на центральную нервную систему (хотя это не универсальное правило).

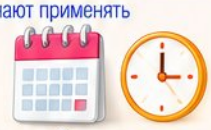
5 Показания к применению стабилизаторов

- Применяются только для профилактики **тяжёлого** течения бронхиальной астмы.
- Используются при сезонных обострениях (например, цветение полыни или тополей).
- Начало применения до предполагаемого контакта с аллергеном не исключает аллергическую реакцию полностью, но направлено на предотвращение тяжёлого течения с приступами удушья и затруднением дыхания.

6 Сроки начала профилактического применения

Для накопления эффекта препараты начинают применять до предполагаемого обострения:

- **Интал — за 3–4 недели.**
- **Кетотифен — за 15 дней.**



Действие развивается постепенно: сначала создаётся депо, затем при контакте с аллергеном течение реакции облегчается.

7 Побочные эффекты стабилизаторов

Кромогликат натрия

- **Сухой кашель.**
- Возникает при ингаляции порошка из капсулы с помощью специального карманного прибора — **Спинхалер**. Капсула внутри прибора раскалывается, и порошок поступает в дыхательные пути, что может провоцировать кашель.
- Обычно помогает приём воды. Если этого недостаточно, применяют бронхорасширяющие или противокашлевые средства, например Синекод, Фалиминт.



Спинхалер

Кетотифен

- Сонливость.
- Замедление реакции.
- Нарушение координации движений.
- Нарушение мочеиспускания.



Эти реакции связаны с действием на центральную нервную систему и сходны с побочными эффектами антигистаминных средств первого поколения.

8 Антигистаминные средства

Блокируют действие гистамина на чувствительные рецепторы тканей.

Первое поколение

- Супрастин.
- Тавегил.
- Фенкарол.
- Диазолин.
- Димедрол.

Основной побочный эффект — снотворное действие.

Препараты проникают через гематоэнцефалический барьер в ткань головного мозга.

Возможно нарушение мочеиспускания: оно может становиться учащённым и болезненным.

Второе поколение

- Лоратадин (Кларитин).
- Цетиризин.
- Дезлоратадин.
- Эбастин (Кестин).
- Левоцетиризин.

Не проникают через гематоэнцефалический барьер и значительно реже вызывают сонливость.

Сонливость всё же может возникать при больших дозировках и длительных курсах, но в целом нехарактерна.

Третье поколение

- Зодак.
- Эриус.
- Зиртек.

По химической структуре это те же вещества, что и во втором поколении, но в наиболее очищенной форме.

Быстро действуют, применяются один раз в день и обладают продолжительным действием.

Побочные реакции отсутствуют.

Формы выпуска включают **капли.**